



Caída

Evalúe Mecanismo de caída

Síncope

ECG

Delirium

Eleve
barandas
Considere
uso
antipsicóticos
Buscar causa

**Mareo
(ortostatismo)**

Reponga
pérdidas
Titulación
AntiHTA
de ser
necesario

**Déficit
neurológico**

Avisar
Neurólogo
turno

Tropiezo

Evalúe
causa
(falta de
anteojos,
calzado
vs problema
hospitalario)

Golpe en la cabeza

**Considere TAC cerebro
sin contraste en:**

- Pacientes anticoagulados o antiagregados
- Otras coagulopatías (DHC, plaquetopenia)
- > 65 años
- Vómitos
- Déficit focal
- Convulsión
- Amnesia
- GSC < 15
- Pérdida de conciencia
- Herida

Golpe en otro sitio

**Considere
Rx cadera en:**

- Acortamiento
- Dolor rotación cadera
- Dolor extensión cadera
- Osteoporosis

**Considere
Rx Lumbar en:**

- Déficit focal
- Deformidad
- Dolor o sensibilidad importante
- Osteoporosis

Considerar
otras Rx según área
comprometida

**Registre evento en ficha y hoja de incidente
Control frecuente**

Según evaluación inicial: cada 30 min hasta cada 2 hrs
Si GCS alterado c/30 min x 2 hrs, luego cada 1 hrs x 4 hrs, luego c/2 hrs

Avise al equipo tratante

